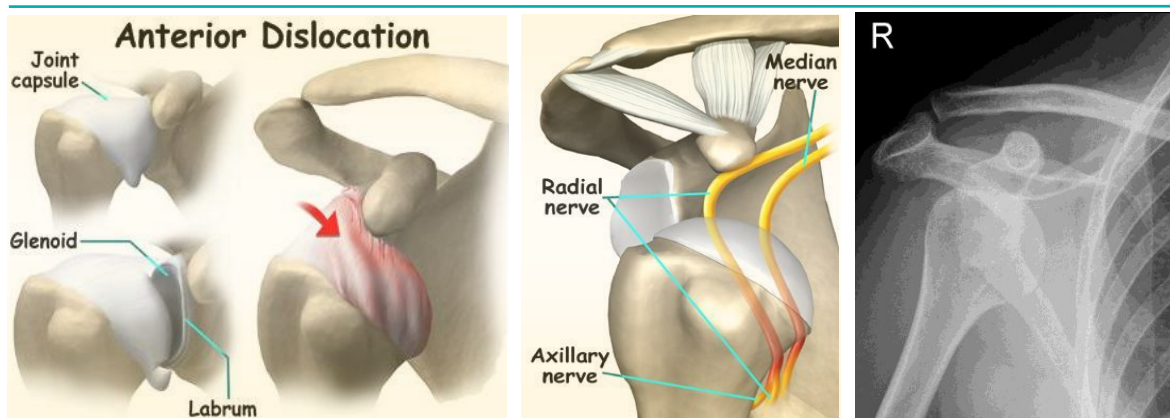


ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ

Γενικά: Η ανατομική κατασκευή της άρθρωσης του ώμου θυσιάζει τη σταθερότητά της στο βωμό της κίνησης, αφού μόνο το 1/3 της κεφαλής του βραχιονίου οστού ενθλακώνεται μέσα στην αβαθή ωμογλήνη· έτσι η σταθερότητα της ωμικής άρθρωσης στηρίζεται κυρίως στον αρθρικό θύλακο, τον επιχείλιο χόνδρο, τους γληνοβραχιόνιους συνδέσμους και τους μυς που την περιβάλλουν και επιτρέπουν εξαιρετικά μεγάλο εύρος κινήσεων. Προφανώς, βάσει αυτών, ο ώμος είναι η πιο συχνά εξαρθρούμενη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Τα εξαρθρήματα προέρχονται είτε από άμεσο ή πιο συχνά από έμμεσο τραυματισμό.

Το **πρόσθιο εξάρθρωμα ώμου** που είναι το συχνότερο (95% των εξαρθρημάτων του ώμου και 45% όλων των εξαρθρημάτων), προκαλείται συνήθως από την πτώση και στήριξη σε τεντωμένο άκρο που βρίσκεται σε έκταση, απαγωγή και έξω στροφή. Συμβαίνει συχνότερα σε άνδρες ηλικίας 20-40 ετών και γυναίκες ηλικίας 60-80 ετών. Σε ηλικίες άνω των 60 ετών συνοδεύεται συχνά από ρήξη των τενόντιων μυών του στροφικού πετάλου του ώμου. Στην παιδική ηλικία το πρόσθιο εξάρθρωμα του ώμου είναι εξαιρετικά σπάνια βλάβη.

Τα **οπίσθια εξαρθρήματα** συμβαίνουν σπανιότατα, μετά από βίαιη αξονική φόρτιση με το άκρο σε απαγωγή και έσω στροφή ή με απευθείας πλήξη του ώμου. Συμβαίνουν συχνά σε επιληπτικές κρίσεις ή σε τροχαία ατυχήματα. Απαιτούν γενική αναισθησία και μυοχάλαση για την ανάταξη ή ακόμα και ανοιχτή χειρουργική ανάταξη για την αποκατάστασή τους.



Κλινική εικόνα: Ο ασθενής με εξάρθρωμα ώμου, συνήθως συγκρατεί το εξαρθρωμένο χέρι με το φυσιολογικό άκρο. Τα εξαρθρήματα του ώμου και της ωμικής ζώνης συνοδεύονται από εντονότατο άλγος, με το πάσχον άνω άκρο να διατηρείται απολύτως ακινητοποιημένο. Το φυσιολογικό περίγραμμα του δελτοειδούς μυός εξαφανίζεται, επειδή έλκεται στο κενό που δημιουργεί η εξαρθρωμένη βραχιόνια κεφαλή. Στα πρόσθια εξαρθρήματα, ο βραχιόνιος διατηρείται σε μικρή απαγωγή, ενώ η δυνατότητα στροφής καταργείται πλήρως. Όταν στο βραχιόνιο οστό ασκηθεί πίεση προς το θωρακικό τοίχωμα, αυτό απομακρύνεται απότομα σαν ελατήριο («σημείο ελατηρίου»). Ψηλαφητή μπορεί να είναι η κεφαλή του βραχιονίου έμπροσθεν της ωμογλήνης ή στη μασχαλιαία κοιλότητα στα χαμηλά πρόσθια μασχαλιαία εξαρθρήματα. Η ωμογλήνη κάτω από το ακρώμιο, στην ψηλάφηση, ανευρίσκεται κενή.

Φυσική εξέταση: Αφού πρωτίστως ελέγξουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*BP, HR, SpO₂*) και διερευνήσουμε για πιθανές συννοσηρότητες (π.χ. *ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.*), προβαίνουμε ακολούθως στην πλήρη κλινική νευραγγειακή αξιολόγηση, με τον έλεγχο λειτουργίας του μασχαλιαίου νεύρου, του βραχιονίου πλέγματος και των σφύξεων της κερκιδικής αρτηρίας, ενώ ο **ακτινολογικός έλεγχος** επιτελείται με προσθιοπίσθια και λοξή λήψη της ωμοπλάτης και διαμασχαλιαία ακτινογραφία, που θα επιβεβαιώσει με ακρίβεια την ύπαρξη και την κατεύθυνση του εξαρθρήματος ή την ύπαρξη άλλης κάκωσης. Κατά την εξάρθρωση της κεφαλής του βραχιονίου θεωρούμε ότι ορισμένα ανατομικά στοιχεία του ώμου μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη. Μεταξύ των συνοδών βλαβών, συχνότερα παρατηρείται αποκόλληση του επιχείλιου χόνδρου, ρήξη πρόσθιων γληνοβραχιόνιων συνδέσμων, ρήξη του αρθρικού θύλακου και οστικές βλάβες στην κεφαλή του βραχιονίου οστού και στην ωμογλήνη.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Επιδιώκουμε γρήγορη και επαρκή αναλγησία, ώστε να επιτύχουμε καλύτερη συνεργασία του ασθενούς, κατά τη διενέργεια ακτινογραφιών και την ανάταξη του εξάρθρηματος.
Χορηγούμε: 1 amp. Dynastat 40 mg (ή Voltaren, Xefo, Vialax) + 1-2 amp. Musco-Ril (ή Norflex) + 1 amp. Apotel-plus, (im) στο γλουτό και αφήνουμε να περάσουν 10-20 λεπτά.
2. Εκτελούμε ακτιν/φίες ώμου (F, Y-view & διαμασχαλιαία) για αποκλεισμό κατάγματος.
Μετά την κλινική εκτίμηση, το εξάρθρημα ανατάσσεται όσο το δυνατόν συντομότερα.
Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 24 ώρες από τον τραυματισμό ή η ανάταξη δεν είναι εφικτή, τότε μπορεί να απαιτηθεί γενική αναισθησία ή ακόμη και ανοικτή ανάταξη.
3. Ενημερώνουμε τον ασθενή για το τι πρόκειται να κάνουμε, για τους χειρισμούς μας, για τον παροδικό πόνο που θα νιώσει και τη συνεργασία που απαιτούμε εκ μέρους του.
4. Προσπαθούμε να ανατάξουμε το εξάρθρημα του ώμου με τη **μέθοδο του Ιπποκράτη** (ή με παραλλαγές της μεθόδου, σε κάθισμα με το άκρο κρεμάμενο) ή με τη **μέθοδο Kocher** (περίπλοκη και επικίνδυνη μέθοδος). Στην περίπτωση επιτυχούς ανάταξης ακούγεται ένα χαρακτηριστικό «γκλουπ». Έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφοροι άλλοι χειρισμοί ανάταξης με έλξη και μοχλούς. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους χειρισμούς ανάταξης είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνοι για τα νεύρα και τα αγγεία και γι' αυτό έχουν εγκαταλειφθεί.



5. Εφαρμόζουμε προσωρινά ελαστικό επίδεσμο (για 15-28 ημέρες) με το πάσχον άκρο σε προσαγωγή και εσωτερική στροφή, ενώ συστήνουμε πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης του μυοτενοντίου πετάλου και των σταθεροποιητών μυών της ωμοπλάτης, ώστε να αποφύγουμε τα καθ' ἑξιν εξάρθρηματα, τα οποία εμφανίζονται συνήθως σε επιληπτικούς ασθενείς, αθλητές ή άτομα με υπερκινητικές αρθρώσεις.
Στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα ο χρόνος ακινητοποίησης συντομεύεται, διότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος δυσκαμψίας του ώμου, ενώ ο κίνδυνος για καθ' ἑξιν εξάρθρημα ώμου ελαττώνεται. Έτσι, δύο (2) εβδομάδες είναι αρκετές, για άτομα ηλικίας > 50-60 ετών.
[Η πιθανότητα επανεξάρθρηματος είναι μεγαλύτερη σε νεαρά άτομα 18-25 ετών, όπου η συχνότητα υποτροπής ανέρχεται στο 66%, ενώ σε άτομα 25-40 ετών μειώνεται στο 40%. Σε νέους αθλητές, ηλικίας < 30 ετών, η συχνότητα υποτροπής φθάνει μέχρι και 80%].
6. Χορηγούμε για 4-7 ημέρες αναλγησία, μαζί με ένα ήπιο σπασμολυτικό των μυών, ήτοι:
 - tab. Xefo Rapid 8 mg ή tab. Mesulid 100 mg 1x1, και tab. Norgesic (450/35) mg 1x3.
7. Σε σπάνιες περιπτώσεις η ανάταξη με χειρισμούς είναι αδύνατη, επειδή παρεκτοπίζεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου πίσω από την κεφαλή του βραχιονίου ή παρεμβάλλεται το μυοτενοντίο πέταλο (στροφικό πέταλο - rotator cuff) ή ο θύλακος ανάμεσα στην ωμογλήνη και την κεφαλή, οπότε χρειάζεται ορθοπαιδική αντιμετώπιση.
8. Μετά την ανάταξη του ώμου διενεργείται εκ νέου αγγειακός και νευρολογικός έλεγχος και έλεγχος του δελτοειδούς μυός. Ο νέος ακτινολογικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για να εκτιμηθεί η ανάταξη και πιθανά συνυπάρχοντα επακόλουθα κατάγματα ή άλλες κακώσεις, ώστε να αποφασισθεί η περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς από ειδικό.
9. Έτσι, επί αποτυχίας ανάταξης, επί οπισθίου εξάρθρηματος ή/και επί άλλων κακώσεων, παραπέμπουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο, για αντιμετώπιση σε Ορθοπαιδική κλινική.